

Midazolam en soins palliatifs

Anxiolyse · prescription anticipée · sédation proportionnée · SPCMD : quelle conduite ?
Adulte — EHPAD · USLD · MAS · FAM · EAM — médecins DOTR en téléconsultation

FICHE PRATIQUE DOTR
VERSION DE TRAVAIL
Septembre 2026 — à valider

À RETENIR

Le midazolam est la molécule de 1^{re} intention des pratiques sédatives. Le diazépam SC n'est pas une voie du RCP et la HAS la déconseille. Anxiolyse, prescription anticipée, sédation proportionnée et SPCMD n'ont ni les mêmes indications ni le même cadre. Une SPCMD ne s'initie pas en téléconsultation.

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · RCP Valium 10 mg/2 mL injectable · HAS 2020 — réponse rapide COVID-19 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD

Arbre décisionnel

Résident en situation palliative : anxiété, agitation, dyspnée, douleur ou détresse mal soulagée

1. Rechercher et traiter une cause : douleur, fécalome, globe vésical, hypoxie, iatrogénie, sevrage... · 2. Accompagnement et mesures non médicamenteuses · 3. Directives anticipées, personne de confiance, proches

? Détresse aiguë ? Asphyxie, hémorragie grave, détresse respiratoire majeure

OUI

B PRESCRIPTION ANTICIPÉE

IDE : appliquer la prescription anticipée **rédigée à l'avance** par le médecin, si elle existe, et appeler le médecin ou le 15. Sans prescription : 15.

NON

? Symptôme **réfractaire** ? Tous les traitements adaptés ont été proposés sans soulagement suffisant

NON

A ANXIOLYSE, TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

Patient vigilant. Traiter la cause, accompagner, traitement symptomatique habituel. **Pas de pratique sédative.**

OUI

? SPCMD envisagée ? Demande du patient (L1110-5-2) ou arrêt d'un traitement de maintien en vie chez un patient hors d'état de s'exprimer

NON

C SÉDATION PROPORTIONNÉE

Midazolam titré ; profondeur et durée **proportionnées au soulagement** ; réversible, réévaluée. Prescription précise, IDE formée, médecin joignable.

OUI

D SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE MAINTENUE JUSQU'AU DÉCÈS (SPCMD)

Décision collégiale (médecin en charge + équipe + au moins un médecin consultant sans lien hiérarchique ; avis possible à distance) · **médecin présent** à l'initiation et jusqu'à stabilisation (hors urgence) · IDE et médecin joignables **24 h/24** (EHPAD sans IDE de nuit : **HAD**) · appui d'une **équipe de soins palliatifs**. **Ne s'initie pas en téléconsultation.**

À CHAQUE ÉTAPE

Réévaluer · **informer** le patient, la personne de confiance et les proches · solliciter l'**EMSP** en cas de doute · **tracer** au dossier : motif, pratique choisie (A à D), prescription, évaluations (RASS, soulagement, effets indésirables), information donnée ; pour une SPCMD, procédure collégiale et motifs. Sédation proportionnée insuffisante : réévaluation médicale et avis EMSP — une SPCMD ne s'envisage **que dans son cadre** (D).

Sources : CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · HAS 2018/2020 — guide SPCMD · SFAP 2009 — définition de la sédation · CSP L1110-5-1, L1110-5-2 · CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · SFAP 2017 — fiches SPCMD

Version de travail à valider (co-direction médicale DOTR, avis d'une EMSP). Repères pour les médecins DOTR : ne remplace ni l'évaluation clinique, ni l'avis de l'équipe de soins palliatifs, ni le protocole de l'établissement. **Proposition DOTR** = choix d'organisation, non issu d'un texte.

Les quatre situations en pratique

A · ANXIOLYSE — PATIENT VIGILANT

Anxiété ou agitation **non réfractaire**. Les causes (anxiété, douleur, fécalome, globe vésical) sont recherchées et prises en charge.

- Accompagnement, présence, mesures non médicamenteuses
- Anxiolytique selon la pratique habituelle, **voie orale** si possible
- La HAS 2020 **ne propose pas de schéma** de midazolam « anxiolytique »

Proposition DOTR

Le midazolam est remboursé en ville dans la seule indication « **sédation en soins palliatifs** » : s'il est envisagé, on entre dans une **pratique sédative** (C), avec ses règles de titration, de surveillance et de traçabilité — pas de « si besoin » sans cadre.

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · Arrêtés 15/12/2021 et 09/02/2022

B · PRESCRIPTION ANTICIPÉE — DÉTRESSE PRÉVISIBLE

« L'élaboration d'un **protocole ou de prescriptions anticipées** est recommandée afin d'anticiper des pratiques sédatives adaptées à ces situations d'urgence et au lieu de soins concerné. »

- Situations : **syndrome d'asphyxie, hémorragie grave**
- Après avis d'un **médecin expérimenté** dans les pratiques sédatives : association opioïde + midazolam possible ; dose de charge de midazolam **2 à 5 mg** en début de titration
- Doses de secours : à **prescrire de façon anticipée**

Proposition DOTR

Rédiger sous la forme « **Protocole de soins infirmiers sur prescription anticipée** » : patient nommé, critères de déclenchement, molécule, dose, voie, nombre maximal d'administrations, surveillance, appel du médecin. Suppose une **IDE 24 h/24** et le midazolam **disponible** dans l'établissement.

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives

C · SÉDATION PROPORTIONNÉE — MIDAZOLAM

Profondeur et durée **proportionnelles au soulagement** du symptôme ; peut être transitoire ou intermittente.

Voie SC (si pas de voie veineuse)

- **Dose de charge** : 0,05 à 0,1 mg/kg, toutes les **20 à 30 min** jusqu'au soulagement ; **réduite** chez le sujet âgé ou fragilisé
- **Entretien** : dose horaire = **50 %** de la dose cumulée de titration
- **Sans dose de charge** : débuter en continu à **0,5 à 1 mg/h**, évaluation toutes les **30 min**
- **Secours** : bolus égal à la dose reçue en 1 h, SC toutes les 20 à 30 min

Évaluer

Profondeur (**RASS**), degré de soulagement, effets indésirables. Midazolam : demi-vie 1,5 à 2,5 h.

Proposition DOTR

Prescription en téléconsultation possible si **IDE présente 24 h/24**, médecin joignable et avis EMSP ; à défaut, relais EMSP / HAD.

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL

D · SPCMD — UN CADRE LÉGAL SPÉCIFIQUE

Indications (L1110-5-2)

- **Demande du patient** : affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court terme, souffrance réfractaire ; ou arrêt d'un traitement engageant le pronostic vital à court terme et susceptible d'entraîner une souffrance insupportable
- **Patient hors d'état d'exprimer sa volonté** : arrêt d'un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable

Mise en œuvre

- **Procédure collégiale** ; médecin consultant sans lien hiérarchique, avis possible à distance ; motifs inscrits au dossier
- « L'infirmier(ère) débutera l'administration des médicaments, **en présence du médecin** qui a décidé et prescrit la sédation »
- Cible **RASS -4 / -5** : évaluation toutes les **15 min** la 1re heure, puis **au moins 3 fois/jour** en EHPAD
- Midazolam **IV** de préférence ; **SC** si IV impossible
- EHPAD **sans IDE de nuit** : **HAD nécessaire** ; lit de repli prévu

Sources : CSP L1110-5-1, L1110-5-2 · CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD · HAS 2020 — pratiques sédatives · SFAP 2017 — fiches SPCMD

DIAZÉPAM SC

Le **Valium injectable** s'administre en **IM, IV lente, perfusion ou intrarectal** : la voie **SC n'est pas dans le RCP**. La HAS (2020) : diazépam « **déconseillé en SC** », son administration au PSE est « inappropriée et plus encore en SC (douleur) ». Demi-vie **32 à 47 h**, métabolite actif **30 à 150 h** : accumulation. **Proposition DOTR** : ne pas l'adopter comme protocole ; si une EMSP le préconise, en discuter avec elle.

Sources : RCP Valium 10 mg/2 mL injectable · HAS 2020 — réponse rapide COVID-19

LE MÉDECIN DOTR EN TÉLÉCONSULTATION

Peut

- Évaluer, rechercher les causes, prescrire le traitement symptomatique (A)
- Rédiger une **prescription anticipée** (B) ; prescrire une sédation proportionnée (C) si les conditions sont réunies — proposition DOTR
- Participer à une **procédure collégiale**, y compris comme médecin consultant à distance ; la loi de 2026 cite « le médecin référent en téléconsultation »
- Mobiliser EMSP et HAD ; recueillir directives anticipées et personne de confiance

Ne peut pas

- **Initier une SPCMD à distance** : médecin présent à l'initiation et jusqu'à stabilisation

Sources : CSP R4127-37-2, R4127-37-3 · Loi n° 2026-404 du 26/05/2026 · HAS 2018/2020 — guide SPCMD · SFAP 2017 — fiches SPCMD

Conditions en ESMS et questions du staff

PRÉREQUIS DANS L'ÉTABLISSEMENT

- **IDE** disponible pour titrer et surveiller ; pour une SPCMD, IDE et médecin joignables **24 h/24**
- Appui d'une **équipe spécialisée en soins palliatifs** (EMSP, HAD, réseau) : « systématiquement » pour une SPCMD hors hôpital
- Loi du 26 mai 2026 : **volet soins palliatifs** dans le projet d'établissement (6° et 7° du L312-1 CASF) et **conventions avec les EMSP**

Midazolam en ville

- Disponible en **officine** depuis 2021-2022 (indication « sédation en soins palliatifs »)
- **Ordonnance sécurisée**, prescription limitée à **28 jours**, délivrance fractionnée de **7 jours**
- **Anticiper** la commande : une officine peut ne pas l'avoir en stock

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · HAS 2018/2020 — guide SPCMD · Loi n° 2026-404 du 26/05/2026 · Arrêtés 15/12/2021 et 09/02/2022 · RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL · SFAP 2021 — midazolam en ville

ÉVALUER LA PROFONDEUR : ÉCHELLE RASS

Richmond Agitation-Sedation Scale — cible selon la pratique choisie.

- **+4** Combatif
- **+3** Très agité
- **+2** Agité
- **+1** Ne tient pas en place
- **0** Éveillé et calme
- **-1** Somnolent
- **-2** Diminution légère de la vigilance (contact visuel < 10 s)
- **-3** Diminution modérée (mouvement à l'appel, sans contact visuel)
- **-4** Diminution profonde (pas de réponse à l'appel, mouvement à la stimulation physique)
- **-5** Non réveillable

SPCMD : cible **-4 / -5**. **Sédation proportionnée** : niveau le plus léger qui soulage.

Sources : RASS · HAS 2020 — pratiques sédatives · HAS 2018/2020 — guide SPCMD

MIDAZOLAM INDISPONIBLE : RECOURS TEMPORAIRE

En cas de difficulté d'approvisionnement, la HAS admet d'autres benzodiazépines :

- **Voie veineuse** : diazépam **5 mg IV lente**, renouvelable une fois après 15 min ; ou clonazépam **0,5 mg IV**, renouvelable une fois après 15 min
- **Sans voie veineuse** : diazépam **5 mg intrarectal**, renouvelable une fois après 15 min ; ou clonazépam **1 mg SC**, renouvelable une fois après 30 min
- Patients à risque (âgés, insuffisants hépatiques ou rénaux, cachectiques) : doses **diminuées de moitié**

Recours **punctuel**, pas un protocole au long cours. Clonazépam SC : voie hors RCP (IV, IM).

Sources : HAS 2020 — pratiques sédatives · RCP Rivotril injectable

RÉPONSES AUX RETOURS DU STAFF

« L'IDE refuse le midazolam SC »

Le RCP du midazolam prévoit la voie SC pour la sédation en soins palliatifs : « si aucun abord veineux n'est accessible, la voie sous-cutanée peut être envisagée ». La réticence se lève par une **prescription écrite précise** (B ou C) et l'appui de l'EMSP.

« La pharmacie n'avait pas de midazolam »

Il est commandable en officine sur ordonnance sécurisée : l'anticiper. En attendant : recours temporaire ci-contre.

« L'EMSP locale utilise le diazépam SC / 4 h »

Hors RCP et déconseillé par la HAS (page 2) : en discuter avec l'EMSP.

Sources : RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL · HAS 2020 — pratiques sédatives

Sources et textes de référence

HAS 2020 — pratiques sédatives — HAS. Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez l'adulte : prise en charge médicamenteuse en situations palliatives jusqu'en fin de vie. Recommandation de bonne pratique, janvier 2020. has-sante.fr/jcms/p_3150631

HAS 2018/2020 — guide SPCMD — HAS. Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ? Guide du parcours de soins, février 2018, actualisé janvier 2020. has-sante.fr/app_164_guide_pds_sedation_web.pdf

HAS 2020 — réponse rapide COVID-19 — HAS. Réponse rapide dans le cadre de la COVID-19 : pratiques palliatives et épargne du midazolam, 30 avril 2020. has-sante.fr/rr_pratiques_palliatives_epargne_midazolam_mel.pdf

SFAP 2009 — définition de la sédation — SFAP. Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes : recommandations, 2009. sfap.org

SFAP 2017 — fiches SPCMD — SFAP. Fiches repères : sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, 2017. sfap.org

SFAP 2021 — midazolam en ville — SFAP. Mémo : utilisation du midazolam en ville (mise à disposition en officine), novembre 2021. sfap.org

RCP Midazolam Viatris 5 mg/mL — Base de données publique des médicaments. Midazolam Viatris 5 mg/mL, solution injectable : RCP (mise à jour 26/07/2024) et conditions de prescription et de délivrance. base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Arrêtés 15/12/2021 et 09/02/2022 — Arrêtés des 15 décembre 2021 et 9 février 2022 : inscription du midazolam injectable sur la liste des spécialités remboursables en ville, indication « sédation en soins palliatifs ». legifrance.gouv.fr

RCP Valium 10 mg/2 mL injectable — Base de données publique des médicaments. Valium Roche 10 mg/2 mL, solution injectable : RCP (19/01/2024). base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

RCP Rivotril injectable — Base de données publique des médicaments. Rivotril 1 mg/1 mL, solution injectable : RCP. base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

CSP L1110-5-1, L1110-5-2 — Code de la santé publique, art. L1110-5-1 (obstination déraisonnable, procédure collégiale) et L1110-5-2 (sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès). legifrance.gouv.fr

CSP R4127-37-2, R4127-37-3 — Code de la santé publique, art. R4127-37-2 et R4127-37-3 (procédure collégiale, médecin consultant, traçabilité). legifrance.gouv.fr

Loi n° 2026-404 du 26/05/2026 — Loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (art. 11, 12, 19, 22). legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/5/26/2026-404

RASS — Sessler CN et al. The Richmond Agitation-Sedation Scale. Am J Respir Crit Care Med 2002 ; version française : Chanques G et al., 2006.

Non trouvé dans les sources consultées : un schéma de midazolam dédié à l'anxiolyse ; une conduite à tenir (seuil respiratoire, flumazénil) propre aux pratiques sédatives palliatives. À arbitrer avec l'EMSP avant validation.

Version de travail à valider (co-direction médicale DOTR, avis d'une EMSP). Repères pour les médecins DOTR : ne remplace ni l'évaluation clinique, ni l'avis de l'équipe de soins palliatifs, ni le protocole de l'établissement. **Proposition DOTR** = choix d'organisation, non issu d'un texte.